



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแล เป็นพิเศษ (ผู้ป่วยเด็ก, ผู้สูงอายุ)

พว. สรรสนีย์ รัตนมนตรี

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

หน่วยฟักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด สยามินทร์ 5

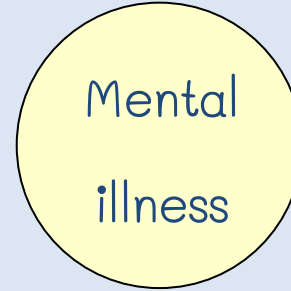
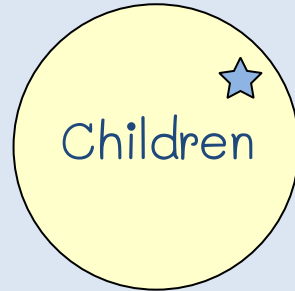
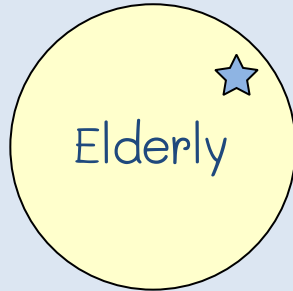


Vulnerable Patient

คือ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถปกป้อง ตัดสินใจ และดูแลตนเองได้ มีแนวโน้มที่อาจเกิดความเสียหายในโรงพยาบาล เช่น การบาดเจ็บ การหกล้ม การละเลยการรักษา และการติดเชื้อ เป็นต้น ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ



Vulnerable Patient





Pathophysiology

Assessment



Content

Nursing Diagnosis

Nursing Care



ผู้ป่วยสูงอายุ



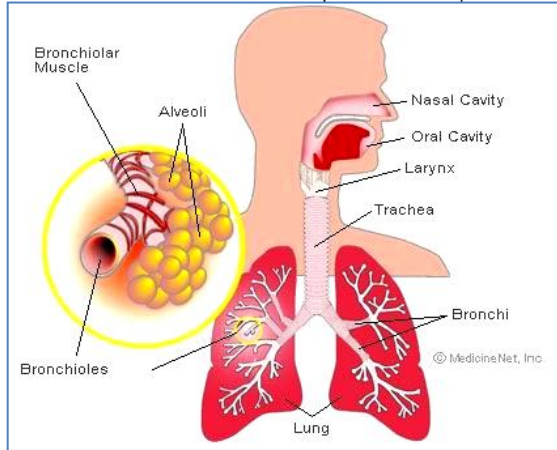
“Frailty can be defined as an accumulation of deficits resulting in an inability to tolerate stress. Fried ’s phenotypic definition of having 3 of the following 5 traits is the basis for the objective evaluation of frailty: slow walking speed, impaired grip strength, self-reported declining activity level, unintended weight loss, or exhaustion”



ระบบหายใจ

ประสิทธิภาพของการ
แลกเปลี่ยนก๊าซลดลง

- ✓ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อปอดลดลง
- ✓ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยหายใจลดลง
- ✓ ผนังทรวงอกแข็ง ขยายตัวได้น้อยลง
- ✓ เยื่อหุ้มปอดแห้ง การขยายตัวและหดตัวของปอดลดลง
- ✓ จำนวนถุงลม Alveoli ลดลงแต่ขนาดใหญ่ขึ้น เกิดถุงลมโป่งพอง
- ✓ Pulmonary compliance ลดลง

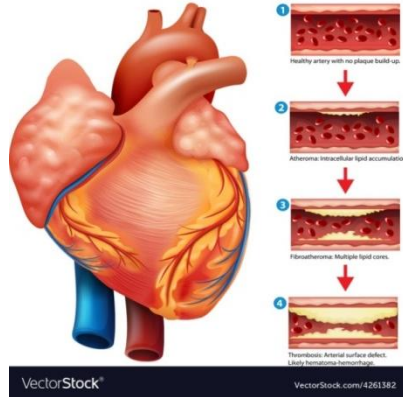


กลไกป้องกันตัวเองของ
ทางเดินหายใจลดลง

- ✓ การทำงานของเซลล์ขนโบกพัดสิ่งแปลกปลอมลดลง
- ✓ การปิดไม่สนิทของฝาปิดกล่องเสียง
- ✓ รีเฟล็กซ์การขย้อนและรีเฟล็กซ์การไอลดลง



FOCUS LIST: เสี่ยงต่อการสำลักและติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (Aspirate pneumonia)



ระบบไหลเวียนเลือด

Myocardial infarction

HR



CO



Arteriosclerosis

FOCUS LIST: เสี่ยงต่อการไหลเวียนเลือดไม่มีประสิทธิภาพ



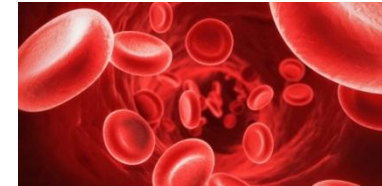
HF

ขนาดของหัวใจอาจโตขึ้น
ผนังหัวใจห้องล่างซ้ายหนาขึ้น

► Myocardial Hypertrophy

กล้ามเนื้อหัวใจมีแคลเซียมเกาะมากขึ้น
ทำให้ระบบสื่อนำคลื่นไฟฟ้าไม่ดี

► Cardiac Arrhythmia



จำนวนเม็ดเลือดแดงลดลง

► Anemia

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานลดลง

► Infection



ระบบประสาทและประสาทสัมผัส



ขนาดของสมองลดลง
จำนวนเซลล์สมองและเซลล์ประสาทลดลง
ประสิทธิภาพการทำงานของสมองน้อยลง
ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ลดลง
การเคลื่อนไหวและความคิดเชิงซ้ำ
เกิดภาวะ Dementia



การมองเห็นไม่ดี รูม่านตาเล็กลง
ปฏิกิริยาการตอบสนองลดลง
แก้วตาเริ่มขุ่นมัว เกิดต้อกระจก
ลานสายตาแคบ กล้ามเนื้อลูกตาเสื่อม
ความไวในการมองภาพลดลง
สายตาวาวขึ้น มองภาพใกล้ไม่ชัด
การผลิตน้ำตาลดลง ตาแห้ง



การเสื่อมของอวัยวะในหูชั้นในมากขึ้น
การได้ยินลดลง หูตึงมากขึ้น
ระดับเสียงต่ำจะได้ยินมากกว่าเสียงสูง
หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในเกิดภาวะ
แข็งตัว เกิดอาการเวียนศีรษะ
และการเคลื่อนไหวไม่คล่องตัว

FOCUS LIST: เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม (Fall) , การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ



ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ



FOCUS LIST: เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้าย/บาดเจ็บจากการจัดท่า



การผลิตน้ำลายและเอนไซม์ลดลง

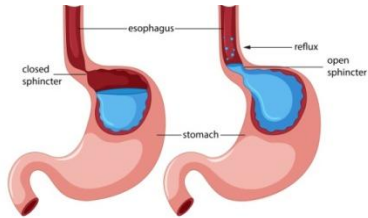
▶ ลิ้นแข็ง และปากแห้ง

การเคลื่อนไหวของหลอดอาหารลดลง

กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารทำงานลดลง
อาหารและน้ำย่อยไหลย้อนกลับ

▶ แสบร้อนบริเวณหน้าอก

เกิดการสำลัก



ขนาดของตับเล็กลง ประสิทธิภาพ

ในการทำลายพิษของตับลดลง

▶ การดูดซึมยาและสารอาหารลดลง

ระบบ ทางเดิน อาหาร

การเคลื่อนไหวของหลอดอาหารลดลง

กระเพาะอาหารว่างนานขึ้น

▶ รู้สึกหิวน้อยลง

การผลิตน้ำย่อย เอนไซม์ในกระเพาะอาหารลดลง
ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวน้อยลง

▶ ท้องผูก

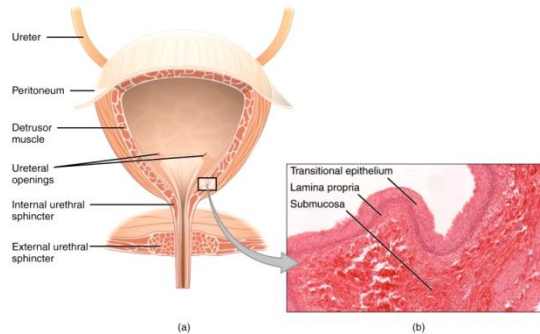
FOCUS LIST: เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกรดไหลย้อน/ไม่สบายในท้อง/ท้องผูก





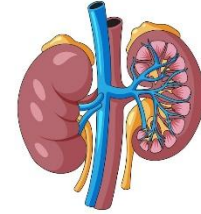
ขนาดของกระเพาะปัสสาวะลดลง
ความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดลดลง
ปริมาณปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้น

▶ ปัสสาวะบ่อย



น้ำหนักและขนาดของไตลดลง
การไหลเวียนเลือดในไตลดลง

▶ อัตราการกรองของไตลดลง



ระบบทางเดินปัสสาวะ

FOCUS LIST: เสี่ยงต่อการกลั้นปัสสาวะไม่ได้/การไม่สมดุลของปริมาณน้ำ





การประเมินสภาพผู้ป่วยสูงอายุ ที่มารับการผ่าตัด



- ☒ ประเมินตั้งแต่ก่อนผ่าตัด
- ☒ การตรวจร่างกายทุกระบบ
- ☒ ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ปัจจุบัน และประวัติการใช้ยา
- ☒ การค้นหาและประเมินความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย



CLINICAL PRACTICE GUIDELINES

The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Perioperative Evaluation and Management of Frailty Among Older Adults Undergoing Colorectal Surgery

Nicole M. Saur, M.D.¹ • Bradley R. Davis, M.D., M.B.A.² • Isacco Montroni, M.D., Ph.D.³
Armin Shahrokni, M.D., M.P.H.⁴ • Siri Rostoft, M.D., Ph.D.^{5,6} • Marcia M. Russell, M.D.^{7,8}
Supriya G. Mohile, M.D., M.S.⁹ • Pasithorn A. Suwanabol, M.D., M.S.^{10,11} • Amy L. Lightner,
M.D.¹² • Vitaliy Poylin, M.D.¹³ • Ian M. Paquette, M.D.¹⁴ • Daniel L. Feingold, M.D.¹⁵
On behalf of the Clinical Practice Guidelines Committee of the American Society of
Colon and Rectal Surgeons



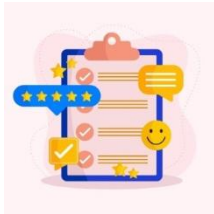
Recommendations:

- ⌘ Frailty screening tools should, ideally, consider patients' mobility, functional activity, cognitive function, comorbidities, and nutritional status
- ⌘ Frail older adults should be screened for postoperative signs and symptoms of delirium and treated appropriately
- ⌘ Frail patients may benefit from a multidisciplinary approach to perioperative care that includes a health care provider with geriatric expertise, in assessing and managing geriatric syndromes (dementia, delirium, propensity for falling, comorbidity, and poly-pharmacy)
- ⌘ Frail older adults should be managed with enhanced recovery protocols (ERPs) are composed of multiple elements such as patient education, carbohydrate loading preoperatively and early feeding postoperatively, optimal fluid resuscitation, multimodality pain control, and early ambulation
- ⌘ Minimally invasive techniques should be considered for frail older adults undergoing colorectal surgery: shorter length of hospital stay, decreased time to return of bowel function, and decreased rates of postoperative pneumonia, wound infection, and ileus



Pre-operative Assessment

เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
ของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการ
ผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด



Assessment

- โรคประจำตัว ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
- ประวัติการใช้ยาประจำ เช่น ยา anticoagulant
- ประวัติการใช้ยาสมุนไพร/วิตามินต่างๆ
- ประวัติการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา
- ประวัติการแพ้ยา/อาหาร รวมทั้งสารเคมีต่างๆ
- ประวัติความเชื่อและวัฒนธรรม
- ปัจจัยทางด้านจิตใจ เช่น ความกลัว วิตกกังวล
- ประวัติทางสังคม เช่น อาชีพ





การตรวจร่างกาย (Physical Examination)

- การประเมินระบบหัวใจและหลอดเลือด
ตรวจดูภาวะซีด ฟังเสียงหัวใจ อากาการบวม
การตรวจ capillary filling time เป็นต้น
- การประเมินระบบหายใจ
ฟังเสียงหายใจ คลำหลอดลมและคอ เป็นต้น
ปัญหาปอดเรื้อรัง เช่น ถุงลมโป่งพอง (emphysema) หอบหืด (Asthma) และ
หลอดลมอักเสบ (Bronchitis) หากมีจะเพิ่ม
อัตราเสี่ยงในการผ่าตัด
- การประเมินระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ตรวจกำลังกล้ามเนื้อ การผิดรูปของอวัยวะ
ประเมินการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ
- ประเมินระบบทางเดินอาหาร
ตรวจบริเวณท้อง ฟัง bowel sound
คลำหน้าท้องทุกส่วน
- การประเมินระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ความผิดปกติของการขับถ่าย ลักษณะปัสสาวะ
รวมทั้ง ประเมินการทำงานไต ส่งผลต่อการขับ
ของเสีย และการควบคุมสมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์
การกำจัดยาระงับความรู้สึก





- การประเมินผิวหนัง

ประเมินผลกดทับ และความเสียหายต่อ
การเกิดแผลกดทับ

High Risk = Op. time > 3 hr.

Operative time. ≥ 3 hrs With risk factor ≥ 1

☐ Position

- ☐ Prone
- ☐ Park Bench/Lateral
- ☐ Lithotomy
- ☐ Supine

☐ Age ≥ 62

☐ BMI < 19 or > 40 (< 43.3 kgs. or > 120 kgs.)

☐ American Society of Anesthesiologists

(ASA) class ≥ 3

 ราชอาณาจักรไทย / Kingdom of Thailand กระทรวงสาธารณสุข / Ministry of Health		วันที่ / Date: _____
ICPI 1. ผู้ป่วยที่มี ICI หรือ ICI ใกล้เคียง > 48 ชม. 2. ผู้ป่วยที่มี ICI หรือ ICI ใกล้เคียง < 48 ชม. 3. ผู้ป่วยที่มี ICI หรือ ICI ใกล้เคียง > 48 ชม.		
แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่มี ICI Sign/Content: Trigger Tool: Modify Early Warning Sign For Postoperative Patient Injury Prevention (1)		
ชื่อผู้ป่วย / Patient Name: _____		

Preoperative (PRE)	Assessment: Risk Factors and Previous Pressure Injury		Previous Pressure Injury ☐ No ☐ Yes: _____ Stage: _____
	☐ No		
	High Risk (2)		
	☐ Yes		
Intraoperative (IN)	Standard Nursing Care		Operative time > 2 hrs. With risk factor > 1 ☐ Position ☐ Prone ☐ Park Bench/Lateral ☐ Libotomy ☐ Supine ☐ Age > 65 ☐ BMI < 18.5 or > 35.0 kg/m ² (kg) ☐ American Society of Anesthesiologists (ASA) class > 3
	☐ OR Skin Prevention Bundle (3) (4, 5) ☐ Maintenance of normothermia ☐ Special padding ☐ Positioning Device ☐ Polyurethane foam dressing (6)		
	Assessment: Skin changes (4) and Pressure Injury (5) (6, 7)		
	☐ No		
Post-operative (PO) (8)	Skin changes (4) / Pressure Injury (5) (6, 7)		Skin changes (4) (8) (9) ☐ No ☐ Yes: OR skin site _____ OR OR ☐ Heeling site _____ OR OR ☐ Bole site _____ OR OR ☐ Dull skin area site _____ OR OR ☐ Pressure Injury (5) (6, 7) (9) ☐ No ☐ Yes: OR 1st stage 1 site _____ OR OR ☐ 2nd stage 2 site _____ OR OR ☐ 3rd stage 3 site _____ OR OR ☐ 4th stage 4 site _____ OR OR ☐ DTBI (10)
	☐ Yes		
	Skin changes (4) / Pressure Injury (5) (6, 7)		
	☐ No		
☐ Early Repositioning (3) (4, 5) ☐ OR OR OR ☐ Change position of external device (9) (10) ☐ OR OR OR ☐ Notify surgeon ☐ OR OR OR ☐ Standard Nursing Care Pressure Injury ☐ OR OR OR ☐ Notify ward ☐ OR OR OR			
Summary By: ☐ OR ☐ OR ☐ Transfer To: ☐ Ward ☐ ICU ☐ Other: _____			
Skin changes: ☐ No ☐ Yes: OR Robotic ☐ Heeling ☐ Edema ☐ Dull skin site			
Pressure Injury: ☐ No ☐ Yes: OR Pressure Injury stage 1/2/3 ☐ DTBI			
Other Wound: ☐ No ☐ Yes: OR MDRT ☐ MDPI ☐ MARS ☐ Trauma Injury ☐ Other: _____			

Progress:	
Operative: _____	
Operative time: _____ hours _____ minutes	
Date: _____	
Item RN (OR) _____ / RN (ICU)	

แบบบันทึก การพยาบาล ก่อนผ่าตัด (Preoperative Nursing Record)

PERIOPERATIVE NURSING RECORD SIRIRAJ HOSPITAL		DATE... 8 / 6 / 63
NAME: HN.	SEX:	OR. NO. 31
		WARD. 721 74
PREOPERATIVE NURSING RECORD		
CONSENT SIGNED	☐ No ☒ Yes	ALLERGY ☒ No ☐ Yes
NPO	☐ No ☒ Yes Since 24.00.00	List
PREMEDICATION	☐ No ☒ Yes (S-Carb 4mg)	
VITAL SIGNS :	CONSCIOUSNESS :	RESPIRATORY STATUS :
Temp. = 36.0 °C	☒ Awake / Oriented	☒ Normal
Pulse = 60 /min.	☐ Calm / Relaxed	☐ Distress
Resp. = 20 /min.	☐ Sedated	O ₂ L/min. via
BP ① 147/61 mmHg ② 134/62 mmHg	☐ Confused	☐ Tracheostomy
O ₂ Sat = 100 %	☐ Unresponsive	☐ Ambu Bag
		☐ Other
LIMITATION : ☐ None		
☐ Visual		
☐ Auditory		
☒ Mobility ① เดินได้		
☐ Loss of Limb (s)		
☐ Prosthesis		
☒ Speech ② พูดได้ (พูดไม่ชัดเล็กน้อย)		
☐ Other		
ON ARRIVAL TO OR. : ☐ None		
☐ NG Tube		
☐ Foley's Catheter Urine = ml : Color		
☐ Chest Tube		
☐ Drain (from ml : color		
☐ Other		
☒ CVP Line		
☐ Art. Line		
☒ IV Infusion		
Acetate 1000 ml @ 80 ml/hr ml		
..... ml		
..... ml		
Pre op. Routine Explained PS. = Done by RN. Time 4.50		
NOTE - BPH, HT, DM (POCT glucose c.m. = 83 mg/dl) - NSTEMI on Plavix 300 mg qd		
INTRAOPERATIVE NURSING RECORD		
PT RECEIVED FROM :	☐ OPD ☐ Ward	TIME : Room In 11:25 Room Out 15:50
	☒ WR ☐ ICU	Incision 12:20 Closure 15:30
	☐ Other	
Pre op. Diagnosis : ๑. ลำไส้ติ่งอักเสบ		
Post op. Diagnosis : Same		
Operation : Distal gastrectomy & D ₂ lymphadenectomy		
Surgeon : อ. ชัยวัฒน์		
1 st Assistant : พ. นพ. ชัยวัฒน์		
2 nd Assistant : พ. นพ. ชัยวัฒน์		
Anesthesiologist : อ. ชัยวัฒน์		
GOAL : ASEPIS MAINTENANCE		
SHAVE IN OR. ☒ No ☐ Yes	☐ Reddened	☐ Other
PREP SITE SKIN CONDITION ☒ Normal	☐ Betadine Scrub	☐ Other
PREP SOLUTION : Scrub	☒ Hibiscrub	
Paint : ☐ Betadine Solution	☐ Alcohol 70%	☐ Other
☒ Hibitane in Alc	☐ Hibitane in Water	
URINARY CATHETER : Inserted in OR ☐ No ☒ Yes		
NG TUBE : Inserted in OR ☐ No ☒ Yes		



การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยสูงอายุ

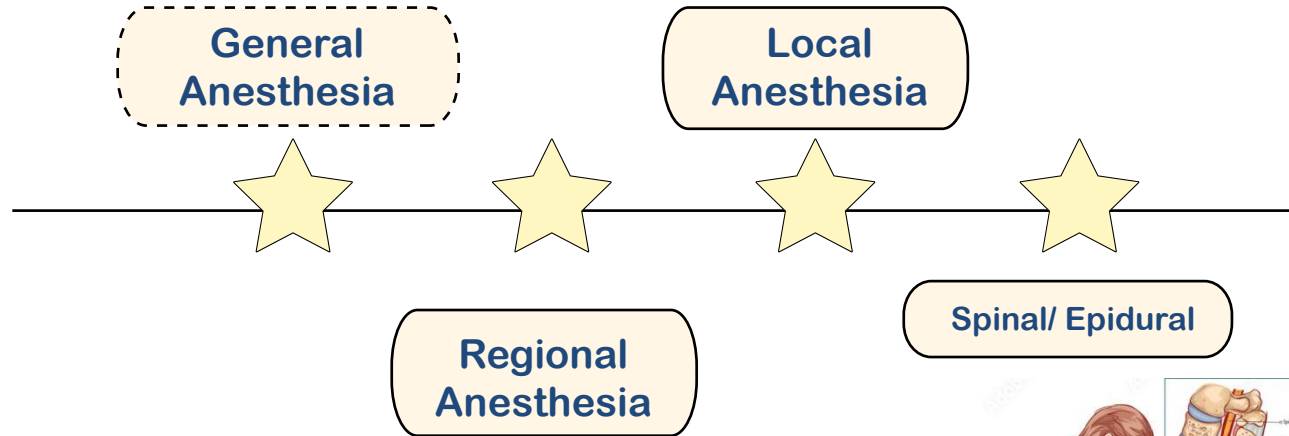
มีการขยายของหลอดเลือดส่วนปลาย

เกิดการสูญเสียความร้อน

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Hypothermia

ลดภาวะเสี่ยงในระบบหัวใจและระบบหายใจ

รวมถึง ภาวะสับสนหลังการผ่าตัด



อาจเกิดภาวะ Total block เกิดจากระดับการชาสูงมาก
ในระดับ T4 ขึ้นไป ผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเต้นช้า
หมดสติ และหยุดหายใจ





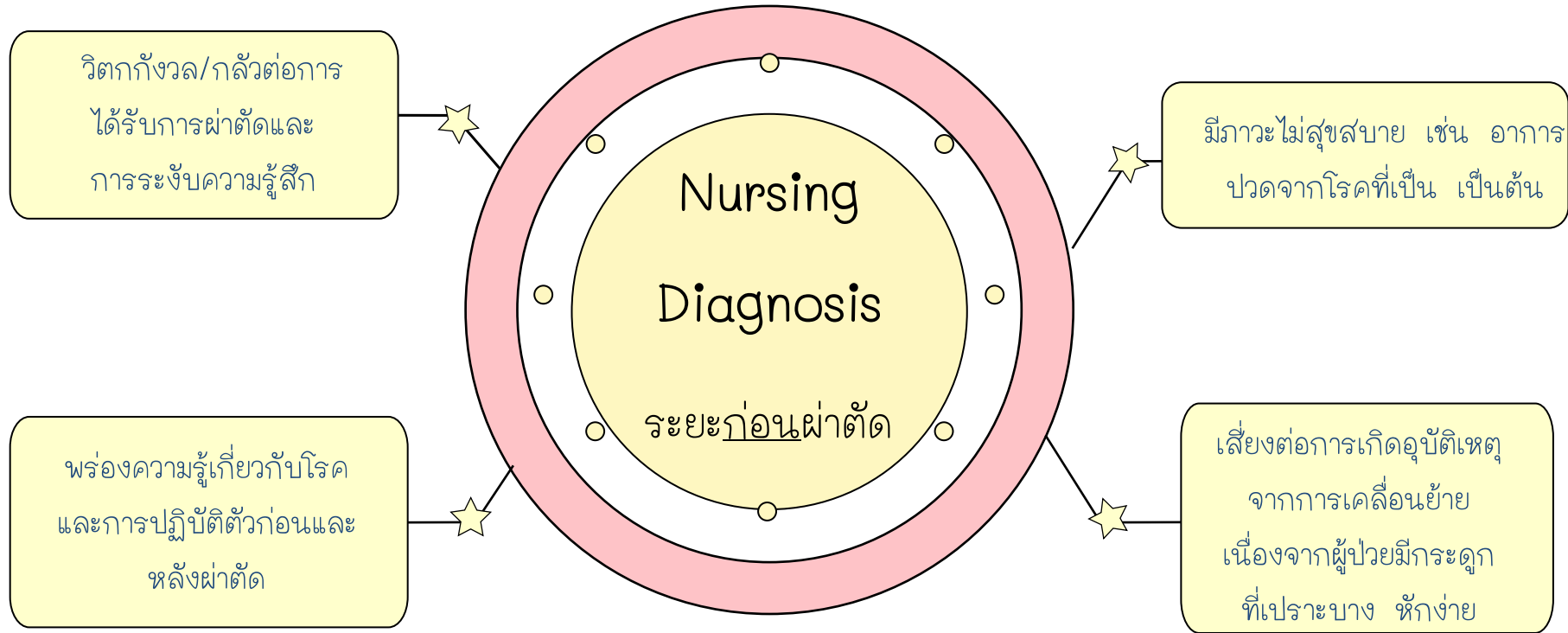
Local anesthetic Systemic Toxicity (LAST)

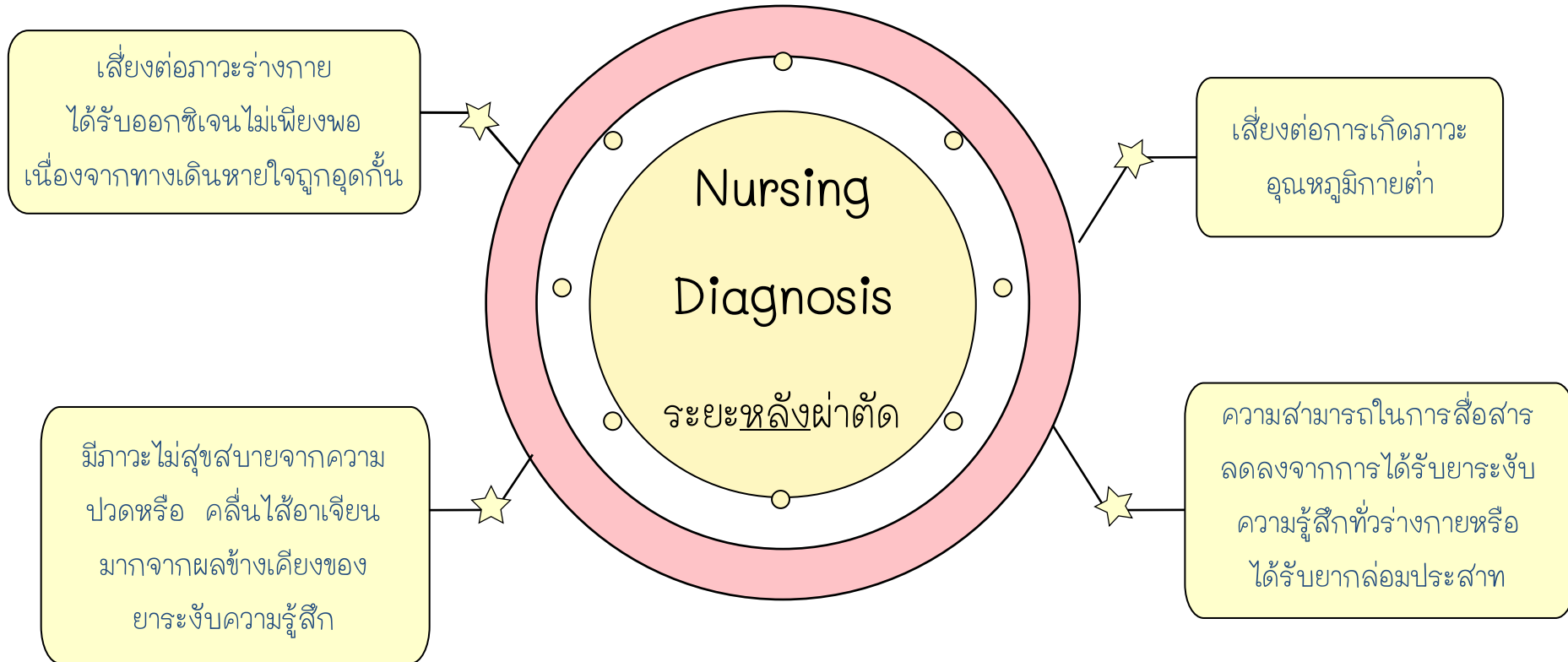
หมายถึง การเกิดอาการหรืออาการแสดงที่ผิดปกติของระบบประสาท (CNS toxicity) และ/หรือ ระบบหัวใจและหลอดเลือด (CVS system) หลังจากได้รับยาชาเข้าไปในร่างกาย



Local anesthetic Systemic Toxicity (LAST)

- ☐ ระดับพิษของยาชาในเลือดต่ำ เกิดการ~~กด~~กระตุ้นระบบประสาท จะมีอาการมีน คีระชะ ขมปาก หูอื้อ ชารอบปาก
- ☐ ระดับพิษของยาชาในเลือดสูงขึ้น เกิดการ~~กด~~กระตุ้นระบบประสาทเพิ่ม จะมีอาการ วุ่นวายสับสน พูดไม่ชัด กล้ามเนื้อกระตุก ชัก
- ☐ ระดับพิษของยาชาในเลือดสูงขึ้น จะเกิดการ~~กด~~กดระบบประสาท จะมีอาการโคม่า กดระบบหายใจ
- ☐ ระดับพิษของยาชาในเลือดสูงมากขึ้น จะเริ่มแสดงอาการ~~กด~~กระตุ้นทางระบบหัวใจ จะมีอาการความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ☐ ต่อจากนั้นถ้าระดับความเป็นพิษในเลือดสูงมาก เกิดการ~~กด~~กดระบบหัวใจ จะเกิดอาการความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้าจนหยุดเต้น







Nursing care



Anxiety

- ▶ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย
- ▶ ประเมินระดับความวิตกกังวล
- ▶ ให้คำแนะนำ อธิบายสิ่งที่ผู้ป่วยสงสัย
- ▶ ให้กำลังใจ สนับสนุนทางด้ายจิตใจ
- ▶ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึก

Lack of knowledge

- ▶ ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วย
- ▶ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด เช่น แนะนำการฝึกการหายใจและการไออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
- ▶ อธิบายวิธีการสังเกตอาการผิดปกติของตนเองหลังผ่าตัดที่ต้องแจ้งแพทย์ทันที
- ▶ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามปัญหา ข้อสงสัย และระบายความรู้สึก
- ▶ ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วยซ้ำหลังได้รับความรู้/คำแนะนำ



Nursing care



Hypothermia

- ▶ เน้น Active warming > Passive warming
- ▶ ประเมินผู้ป่วยตั้งแต่ Pre-op: Pre-warming
- ▶ Monitor Core Temperature: esophageal probe, rectal probe
- ▶ จัดหาผ้าห่มอุ่น หรือ forced air-warmer ตั้งแต่ waiting room (ในกลุ่มที่มี High risk for hypothermia)
- ▶ ตำแหน่งการ warmer: แกนกลางลำตัว หรือ วางตรงหน้าอก
- ▶ ไม่เปิดเผยร่างกายผู้ป่วยให้สัมผัสกับอากาศภายนอกโดยไม่จำเป็น
- ▶ ให้สารน้ำ/เลือดอุ่น หรือให้ออกซิเจน



Nursing care



Hypoxia

- ▶ ประเมินภาวะพร่องออกซิเจน
อัตราการหายใจ ลักษณะการหายใจ
- ▶ จัดทำแผนการดูแล
- ▶ กระตุ้นให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึกๆ
และไออย่างมีประสิทธิภาพ
- ▶ ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจน

Pressure injury

- ▶ ประเมินผิวหนังตั้งแต่มองผ่านผ้าตัด
- ▶ ประเมิน Risk factor
- ▶ เตรียมอุปกรณ์ป้องกันผิวหนัง
- ▶ บันทึกและส่งต่อข้อมูลดูแลต่อเนื่อง





Nursing care



Fall

- ▶ ประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิด Fall
- ▶ ได้แก่ การทรงตัวไม่ดี แขนขาอ่อนแรง มีประวัติวิ่งเวียน หน้ามืด ประวัติชัก หรือมีอาการสับสน ปั่นติ่ง เป็นต้น
- ▶ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้เคาน์เตอร์พยาบาล
- ▶ แนะนำการปฏิบัติกิจกรรมบนเตียง

Post-operative Delirium

- ▶ ประเมิน Risk factors ได้แก่ อายุ > 65 ปี โรคประจำตัว มีภาวะสมองเสื่อม ภาวะพร่องการมองเห็น/ได้ยิน เป็นต้น
- ▶ คัดกรองภาวะ POD
- ▶ ให้การพยาบาล ดังนี้
 - ให้ข้อมูลบุคคล สถานที่ และเวลาสม่ำเสมอ
 - สื่อสารโดยใช้ประโยคสั้นๆ เข้าใจง่าย
 - จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบ ลดสิ่งกระตุ้น
 - จัดการความปวด ประเมินความปวดเป็นระยะ และลดระดับความปวด
 - ไม่ผูกมัด เมื่อไม่จำเป็น



Monitoring

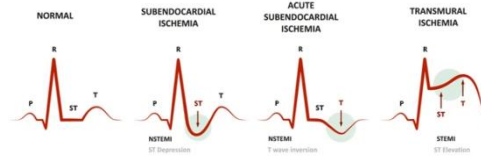


- ▶ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด DVT
- ▶ จัดเตรียมเครื่อง Compressive device

DVT

- ▶ สังเกตอาการเจ็บหน้าอก
- ▶ Monitor EKG, V/S,
- ▶ ติดตามค่า Cardiac enzyme

STEMI



Stroke

- ▶ รายงานแพทย์ทันที เพื่อประเมินและตามทีม Stroke Fast Track
- ▶ ประเมินอาการแสดงของภาวะ Stroke
- ▶ ประเมิน GCS, Motor power





ELSEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com)

Journal of PeriAnesthesia Nursing

journal homepage: www.jopan.org

Continuing Education

Nurse's Role in Perioperative Neurological Evaluation and Management to Lower the Risk of Acute Stroke in Patients Undergoing Noncardiac, Nonneurological Surgery

Martha Power, APRN, SCR.N, FAHA^{a,*}, Claire Bentley, MD^b, Curtis Benesch, MPH, MD^c

^a Martha power- Retired, Former Stroke Coordinator, West Virginia University Medicine, Morgantown, WV

^b Claire Bentley- Department of Anesthesiology

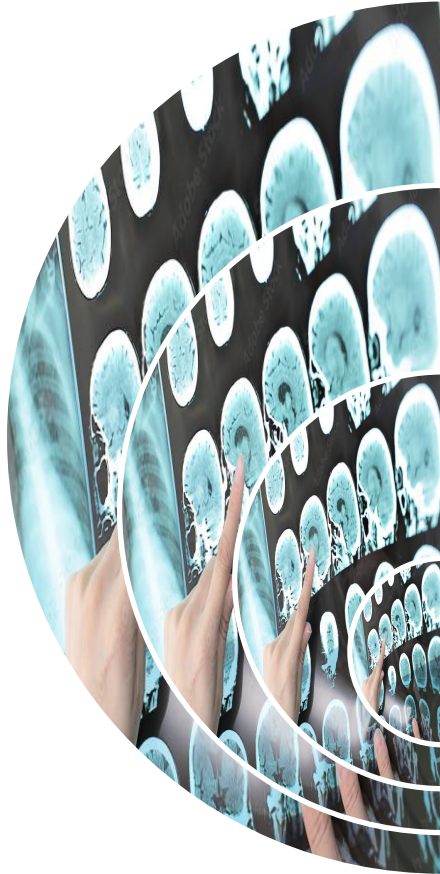
^c Curtis Benesch- Department of Neurology, University of Rochester Medical Center, Rochester, NY



Risk factors for perioperative stroke



- ⌘ Age greater than 60
- ⌘ Renal disease
- ⌘ Prior transient ischemic attack or stroke
- ⌘ Myocardial infarction within 6 months
- ⌘ Atrial fibrillation
- ⌘ Hypertension
- ⌘ Chronic obstructive pulmonary disease
- ⌘ Current smoking
- ⌘ Female sex
- ⌘ Diabetes mellitus
- ⌘ Types of procedures (thoracic, head and neck, intra-abdominal, vascular, transplant, orthopedic)



Intraoperative nurses recognize that overall decline in cardiac, pulmonary, and renal function decreases older adults' ability to maintain homeostasis during times of stress such as surgery.

Intraoperative nurse play a key role in advocating for the best practices discussed below.

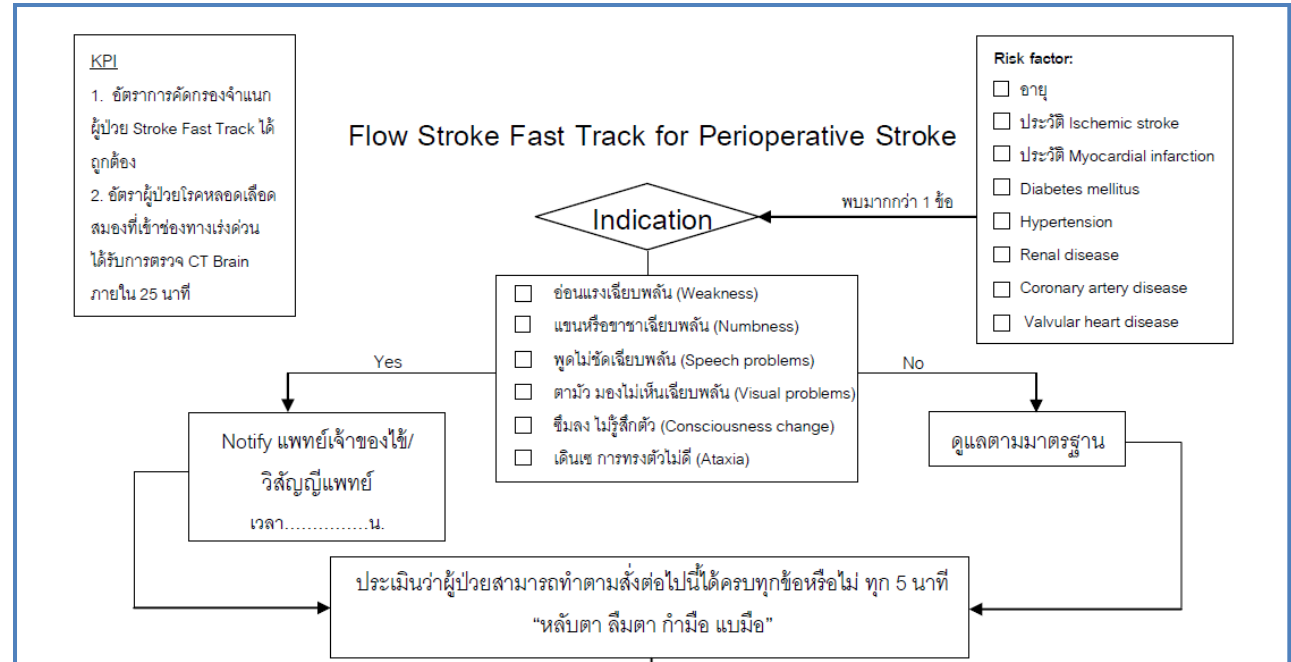
In addition, they communicate intraoperative complications and interventions during the transition of care to the PACU, which may increase vigilance for identification of stroke symptoms.

Anesthesia providers rely on blood pressure monitoring in conjunction with oxygen saturation to ensure adequate perfusion to vital.



PACU nurses should be aware of the patient's baseline and routinely performing neurological assessments in high-risk patients for early stroke recognition.

- Level of arousal
- Speech/language
- Motor function





ครั้งที่	เวลา	GCS (E V M)	Hand grip ปกติ ผิดปกติ	EOM ปกติ ผิดปกติ	Eye deviation ปกติ ผิดปกติ	Flex both knees ปกติ ผิดปกติ
0	__ : __	☐ ☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
1	__ : __	☐ ☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
2	__ : __	☐ ☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
3	__ : __	☐ ☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
4	__ : __	☐ ☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
5	__ : __	☐ ☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
6	__ : __	☐ ☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

Yes

Activated Stroke Fast Track

Tel. เวลา.....น.



การตรวจคัดกรองทางระบบประสาทหลังผ่าตัด

การประเมิน	ปกติ	ผิดปกติ
Eye deviation ตามองตรง		
Pupil size and light reflex ตรวจขนาดของรูม่านตาและการตอบสนองต่อแสง	1 มม. 2 มม. 3 มม. 4 มม. 5 มม. 6 มม. 7 มม. 8 มม. 9 มม.	รูม่านตาสองข้างมีขนาดเท่ากันและตอบสนองต่อแสงโดยการหดตัว
Flex both knee เอามือประคองข้อเข่าของผู้ป่วยให้เข่าทั้งสองข้างตั้งขึ้น	เมื่อปล่อยมือ เข่าจะตั้งอยู่ได้หรือกางออกเท่ากันอย่างสมมาตร	เมื่อปล่อยมือ เข่าที่อ่อนแรงจะตกลง

(ไม่ต้องตรวจให้ผู้ป่วยมี femoral catheter)

การตรวจคัดกรองทางระบบประสาทหลังผ่าตัด

Hand grip ตรวจแรงกำมือ 2 ข้าง โดยให้ผู้ป่วยกำนิ้วมือผู้ตรวจดังรูป		
EOM (เฉพาะนวนอน) 		
Glascow Coma Scale (GCS)	Verbal Response	Motor Response
Eye Opening		
4 - ตื่นตาได้เอง	5 - พูดชัดดี ตามคนรู้เรื่อง	6 - ทำตามคำสั่งได้
3 - เปิดม่านตา	4 - พูดได้เป็นประโยค แต่สับสน	5 - บิดตัวหนึ่งข้างได้
2 - ตื่นตามองหรือพูดไม่ชัด	3 - พูดได้เป็นคำๆ เป็นท่อนๆ สั้นๆ	4 - ขยับได้เล็กน้อย
1 - ไม่ตื่นตามอง	2 - ออกเสียงที่ไม่มีควาหมาย	3 - Decortication posture
	1 - ไม่ตอบสนอง	2 - Decerebration posture
		1 - ไม่มีการขยับ



สรุปประเด็น

- ✓ การประเมินร่างกายตามพยาธิสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งด้านจิตใจ
- ✓ ผู้ป่วยกลุ่ม high risk ต่างๆ เน้นให้การพยาบาลเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
- ✓ การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทำตั้งแต่ pre-op.
- ✓ การส่งต่อข้อมูลการดูแลต่อเนื่อง





ผู้ป่วย
เด็ก

พยาธิสรีรภาพยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่

- ระบบหายใจ
- ระบบไหลเวียนเลือด
- ระบบประสาทส่วนกลาง
- ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
- ระบบทางเดินอาหาร
- ระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบหายใจ

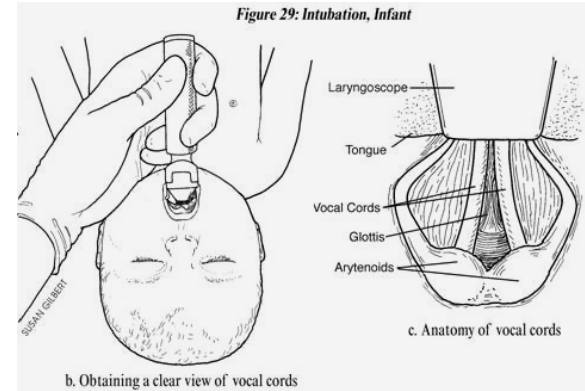
ขนาดศีรษะใหญ่ คอสั้น ลิ้นค่อนข้างใหญ่

กล่องเสียงอยู่สูงและแคบ

- ▶ ใช้ Laryngoscope และการใส่ท่อช่วยหายใจ
จึงยากกว่าผู้ใหญ่

Basal metabolic rate สูง

- ▶ ความต้องการออกซิเจนจึงสูงด้วย





ระบบไหลเวียนเลือด

ระบบประสาทอัตโนมัติที่ไม่สมบูรณ์

▶ หลังสาร Catecholamines ปริมาณ
จำกัด การสะสมที่กล้ามเนื้อหัวใจน้อย

หากทารกได้รับยาระงับความรู้สึกจึงต้อง
ระวังเป็นพิเศษ

▶ฤทธิ์ของยาจะลดการทำงานของ
กล้ามเนื้อหัวใจได้

เด็กเล็กความสามารถในการทำงาน
ของกล้ามเนื้อหัวใจน้อยกว่าผู้ใหญ่

CO ↓

HR ↑

เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพียงพอ





ระบบประสาทส่วนกลาง

ระบบประสาทส่วนกลาง
ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์

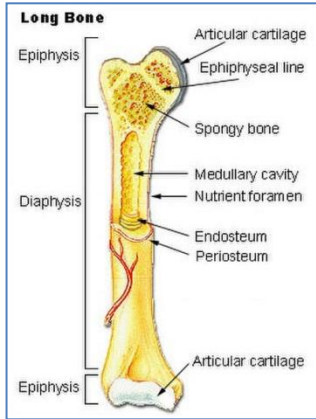
Sympathetic ↓
Catecholamines ↓

ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของร่างกาย

- ▶ Hypoxia
- ▶ Hypothermia

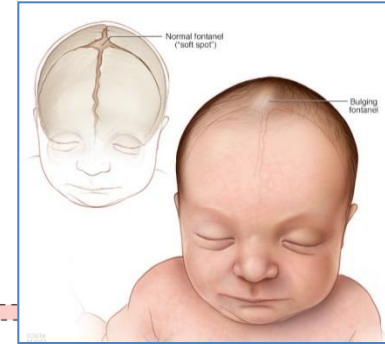


ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ



Epiphysis ยังไม่
เชื่อมต่อกันสนิท

Fontanels
ยังเปิดอยู่



Skin

เด็กทารกมีปริมาณไขมันใต้ผิวหนังน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่
ของร่างกาย การสูญเสียความร้อนในทารกจึงเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว

ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
ในการจัดท่านอนต่างๆ



ช่วงเดือนแรก

ตับยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่
หน้าที่ผลิตเอนไซม์ต่างๆ และปริมาณเลือดที่ไป
เลี้ยงตับมีน้อย

- ▶ การเปลี่ยนแปลงยาที่ตับจึงเกิดขึ้นได้น้อยกว่า
วัยผู้ใหญ่



ระบบ
ทางเดิน
อาหาร

เดือนที่สอง

ตับจะทำงานได้มากขึ้นเกือบเท่ากับผู้ใหญ่
การสร้างน้ำลายในวัยทารกมีมาก

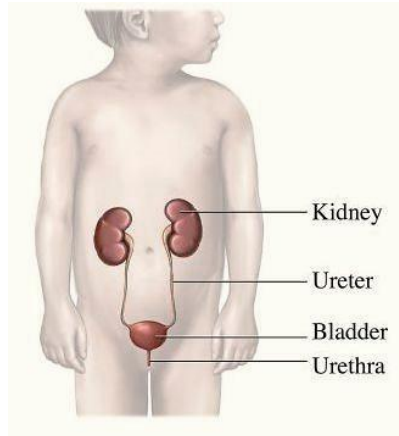
- ▶ การให้ยากลุ่ม Anticholinergic
ก่อนผ่าตัด เพื่อป้องกันการเกิดหัวใจเต้นช้า
ในระหว่างผ่าตัด จะมีผลต่อการลดการหลั่ง
น้ำลายและสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจ



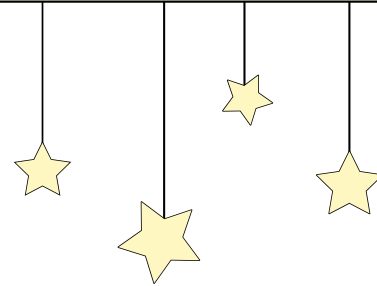
ช่วงเดือนแรกของชีวิต

อัตราการกรอง (GFR) และการขับ Creatinine ยังทำงานได้ไม่เต็มที่
ความสามารถในการขับยาออกจากร่างกายเป็นไปอย่างช้าๆ ส่งผลถึงการปรับ
สมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย

- ▶ การใช้ยาในเด็กต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการสะสมของยา



ระบบทางเดินปัสสาวะ





การประเมินสภาพผู้ป่วยเด็ก ที่มารับการผ่าตัด



- ☑ ประเมินก่อนผ่าตัด ประวัติการคลอด โรคประจำตัว
- ☑ ผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ☑ ประเมินสภาพจิตใจ
- ☑ วิธีการได้รับยาระงับความรู้สึก



ELSEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Journal of PeriAnesthesia Nursing

journal homepage: www.jopan.org

Best Practice

Development of an Evidence-Based Pediatric Preoperative Risk Assessment Checklist

Myrna Mamaril, DNP, RN, NEA-BC, CPAN, CAPA, FAAN, FASPAN*

Perioperative Services, The Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD



Pediatric respiratory adverse events (PRAEs) : hypoxia

- ⌘ high metabolic requirements
- ⌘ the need to consume and utilize oxygen
- ⌘ an immature respiratory, center of the brain, immature bronchi
- ⌘ an under developed alveolar-capillary gas exchange system
- ⌘ retaining increased carbon dioxide due to the residual effects of anesthesia
- ⌘ opioids reversed
- ⌘ Muscular weakness of protective reflexes
- ⌘ increased sensitivity to hypoxia



Risk factor of respiratory complications

- ⌘ age (prematurity, ≤ 3 years of age)
- ⌘ gender (male)
- ⌘ ASA physical status (II and III)
- ⌘ type of anesthesia (general)
- ⌘ type of surgery
- ⌘ morbid obesity
- ⌘ congenital anomalies/syndromes (Down's, skeletal dysplasia)
- ⌘ airway co-morbidities (reactive, difficult airway, tracheomalacia)
- ⌘ pre-existing pulmonary disorders (asthma, upper respiratory infection, obstructive sleep apnea/disordered breathing)
- ⌘ pre-existing neuromuscular disorders
- ⌘ pre-existing cardiac disorders



Pre-operative Assessment

- อายุ และน้ำหนักตัว เพื่อดำหนดปริมาณสารน้ำและขนาดยาต่างๆ
- ประวัติการคลอด เนื่องจากเด็กที่คลอดก่อนกำหนดจะมีอุบัติการณ์การหยุดหายใจ (Apnea) ภาวะหัวใจเต้นช้ามากกว่าปกติ จนกว่าอายุมากกว่า 1 ปี
- ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ



ประเมินสภาพจิตใจเด็ก

- ☒ ผู้ป่วยเด็กจะรู้สึกว่าจะถูกแยกจากครอบครัว
- ☒ สูญเสียการควบคุมตัวเอง
- ☒ กลัวการบาดเจ็บและการเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น
- ☒ ผู้ป่วยเด็กจะไม่สามารถทำความเข้าใจหรือซักถามเหตุผลของการผ่าตัดได้เท่ากับผู้ใหญ่
- ☒ ผู้ป่วยเด็กจะมีความเครียด
- ☒ แสดงพฤติกรรมของการถูกแยกจากครอบครัว



การเฝ้าผู้ปกครอง

- ☑ ผู้ปกครองมีความวิตกกังวลหรือไม่
- ☑ ความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง: โรค/การผ่าตัดที่ได้รับ
การเตรียมอุปกรณ์ เช่น น้ำ/นม มาให้เด็กเมื่อตื่นดี
- ☑ ความสามารถในการดูแลเด็ก เวลาที่สามารถให้เข้ามาดูแล
การให้คำอธิบายเพิ่มเติมเมื่อสงสัย





การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยเด็ก

การครอบหน้ากาช่วยหายใจแล้วให้ผู้ป่วยเด็กดมก๊าซ

นำสลบ เหมาะสำหรับเด็กทารกและวัยเรียน



Inhalation Anesthesia

Intravenous Anesthesia

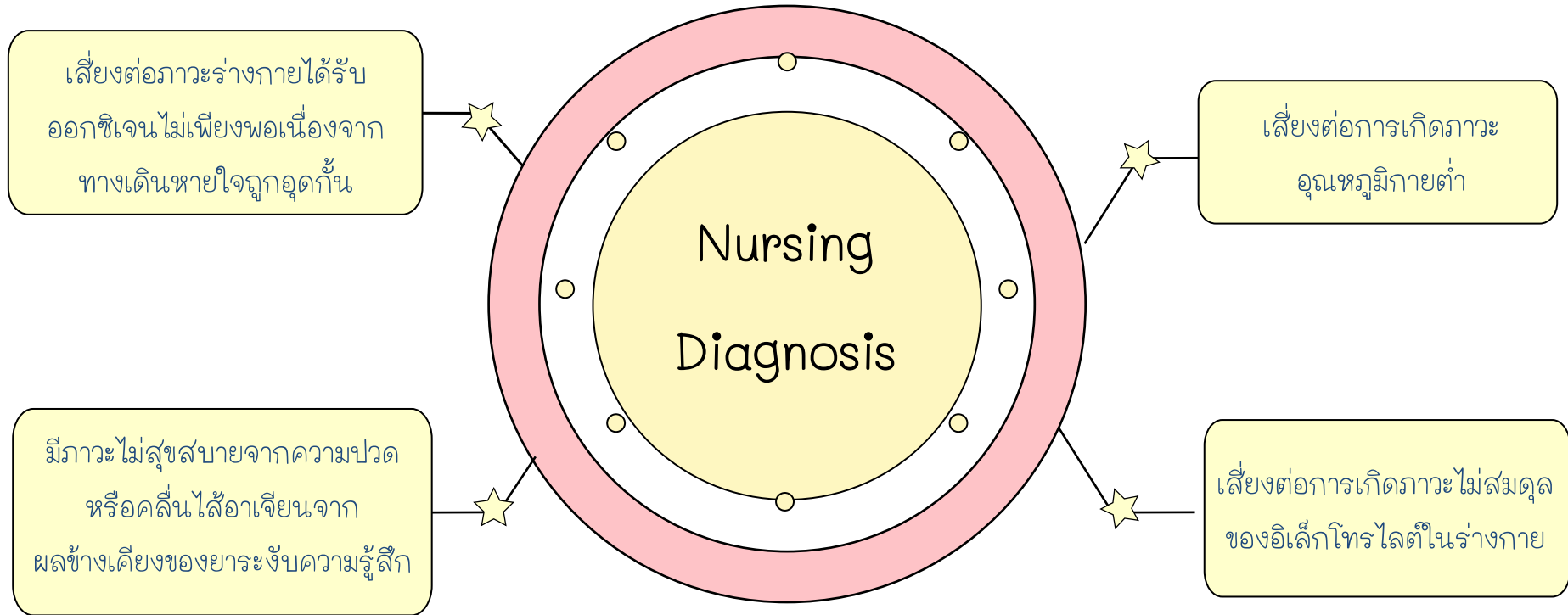
เกิดภาวะ Apnea ได้ง่าย
จากฤทธิ์ยา Opioid

General
Anesthesia

Local Anesthesia

Muscle
relaxant

ทารกจะมีความไวต่อยาคลายกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ใหญ่ ทำให้ต้องการระดับยาในพลาสมาต่ำกว่าปกติ จำเป็นต้องลดขนาดของยาลงเมื่อใช้ในเด็ก เนื่องจากการขับยาออกทางไตยังทำได้ไม่เต็มที่ ทำให้ยากลุ่มน้ำออกฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นาน





Nursing care



ส่งเสริมการระบายอากาศ

ระยะหลังผ่าตัด ผู้ป่วยเด็กอาจหายใจได้ไม่เต็มที่ การระบายของ
ยาดมสลบออกมากับลมหายใจ โดยเฉพาะก๊าซไนตรัสออกไซด์ ขับออก
จากเลือดเข้าสู่ถุงลมปอดอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับออกซิเจนลดลง

- ☒ ดูแลเปิดทางเดินหายใจของผู้ป่วยเด็กให้โล่งอยู่เสมอ
- ☒ จัดท่าให้นอนตะแคง ผ้าห่มรองศีรษะเพื่อป้องกันไม่ให้
ลื่นตกไปปิดกั้นทางเดินหายใจ
- ☒ ฝ้าภาวะพร่องออกซิเจน โดยตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือดแดง
- ☒ ดูแลให้ได้รับออกซิเจนอย่างเหมาะสม

Recovery position





ภาวะสมดุลน้ำและเกลือแร่

เด็กมีอัตราการกรองที่หน่วยไต
เพียงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับ
ผู้ใหญ่ และความสามารถในการเก็บ
กักน้ำยังไม่เต็มที่ ปัสสาวะของเด็ก
จะมีความเข้มข้นน้อย และมีระดับ
โซเดียมสูง



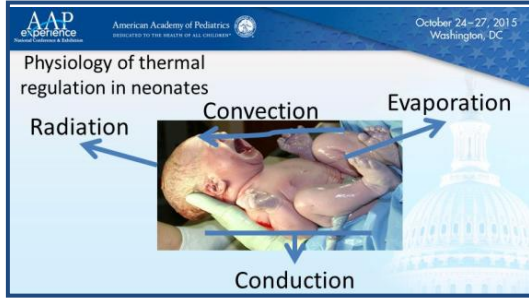
Nursing care



- ☑ บันทึกปริมาณ I/O เพื่อประเมินภาวะน้ำขาดหรือน้ำเกิน
- ☑ ดูแลให้ได้รับปริมาณสารน้ำและเกลือแร่ตามความต้องการของร่างกาย
- ☑ ติดตามค่าสัญญาณชีพ ได้แก่ ค่าความดันโลหิต และชีพจร อย่างใกล้ชิด



การป้องกันการสูญเสียความร้อน





การดูแลด้านจิตใจ

ผู้ป่วยเด็ก เมื่อเข้ารับการผ่าตัด จะพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่ และบุคคลอื่นที่ไม่คุ้นเคย มีความวิตกกังวล หวาดกลัว สับสนจึงต้องให้การดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยเด็กร่วมด้วย

- ให้ความจริงกับเด็กในเรื่องที่เข้าใจง่าย
- นำของเล่นที่เด็กชอบและของรักที่คุ้นเคยติดตัวมาตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัดจนถึงระยะหลังผ่าตัด จะช่วยให้ผู้ป่วยเด็กเกิดความมั่นคงทางจิตใจ รู้สึกปลอดภัย และคลายความวิตกกังวลได้



การดูแลความสบาย

ควรดูแลให้ผู้ป่วยสบายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
วิธีการจัดการความปวดหลังผ่าตัด โดยไม่ใช้ยา ได้แก่

- ☒ การสัมผัส การอุ้ม
- ☒ การทำให้ร่างกายอบอุ่น
- ☒ การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล





ELSEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Perioperative Care and Operating Room Management

journal homepage: www.elsevier.com/locate/pcorm

Prevalence and Contributing Factors Associated With Postoperative Pain in Pediatric Patients: A Cross-Sectional Follow-up Study

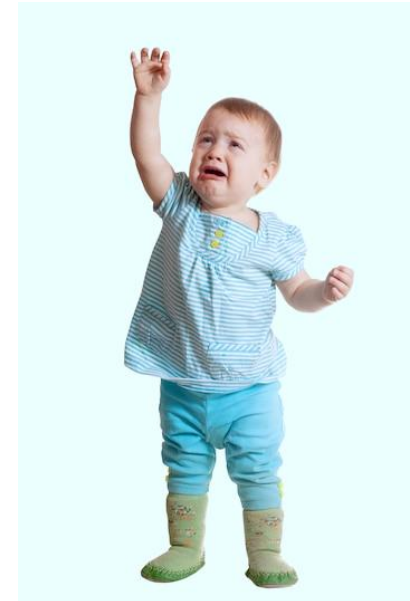
Zemenay Ayinie Mekonnen^a, Debas Yaregal Melesse^{b,*}, Habitamu Getinet Kassahun^c,
Tesera Dereje Flatie^d, Misganaw Mengie Workie^e, Wubie Birlie Chekol^f



“Moderate to severe pain in the pediatric population was associated with physiological, psychological, and emotional adverse effects”

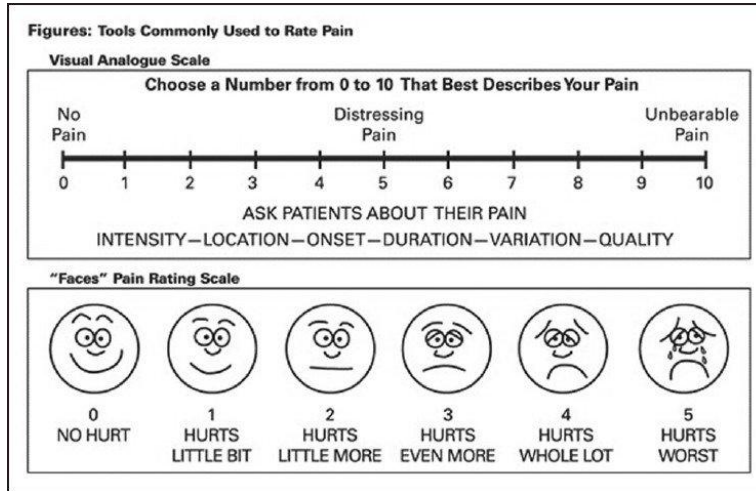
Predictors of postoperative pain

- Preoperative analgesia
- Intraoperative analgesics administered
- Chronic pain
- Type of surgery
- Preoperative anxiety
- Preoperative pain
- Incision length





“The gold standard pain assessment tool for pain severity is self-report”



Visual Analog Scale

FACES Scale



มหาวิทยาลัยพระปริชารินทร์
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

Newborn & Infant Pain Scale (NIPS)

สำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS)

สำหรับเด็กอายุมากกว่า 1-6 ปี

เกณฑ์	คะแนน			เกณฑ์	คะแนน			
	0	1	2		0	1	2	3
สีหน้า	เฉยๆ สบายๆ	แสบๆ ปากเบะ จุกย่น คิ้วย่น ปิดตานั่น		สีหน้า	ยิ้ม	เฉยๆ	เบ้	
ร้องไห้	ไม่ร้อง	ร้องคราง	กรีดร้อง	ร้องไห้		ไม่ร้อง	คราง / ร้องไห้	หวีดร้อง
การ หายใจ	สม่ำเสมอ	เร็วขึ้นหรือช้าลง หรือกลืนหายใจ		การส่ง เสียง	พูดสนุก / ไม่พูด ร้อง / ไม่ บ่น	บ่นอื่น ๆ เช่น หิวนม หาแม่	บ่นปวดหรือบ่นปวด ร่วมกับบ่นอื่นๆ	
แขน	วางสบายๆ	งอ		ท่าทาง (ลำตัว)		ธรรมดาๆ สบายๆ	ด้น/เกร็ง/สั่น/ย่น/ ด้นจนถูกจับตึงได้	
ขา	วางสบายๆ	งอ / เขยียด		สัมผัสแผล/ บริเวณปวด		ไม่สัมผัส	เอื้อมมือมา/แตะเบา ๆ/ตะปบ /เอื้อมมือมาจนต้องจับมือหรือ แขนไว้	
ระดับ การตื่น	หลับ / ตื่น	กระสับกระส่าย ง่วงวาย		ขา		ท่าสบาย	ปิดตัว/ตะ/ดึงขาหนี/เกร็ง/ ย่น/ด้นจนถูกจับหรือตึงได้	

CHEOPS



สรุปประเด็น

- ☑ การประเมินร่างกาย&จิตใจ
- ☑ การประเมินผู้ปกครอง: ความวิตกกังวล ความสามารถในการดูแลเด็ก
- ☑ การให้คำแนะนำเพิ่มเติม: การเตรียมน้ำ/นม เวลาที่จะให้เข้ามาดูแลเด็กก่อนและหลังผ่าตัด





ผู้ป่วย
Mental
illness



Depression



Insomnia



Schizophrenia



Bipolar disorder



การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการผ่าตัด

มุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวมเน้นความปลอดภัย การสื่อสารที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และการจัดการความวิตกกังวล โดยร่วมมือกับทีมแพทย์ในการปรับยาให้เหมาะสม สังเกตภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปฏิกริยาระหว่างยา การเตรียมตัวผู้ป่วยและญาติให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมให้สงบปลอดภัย เพื่อลดภาวะสับสนและพฤติกรรมก้าวร้าว



★ การพยาบาลที่สำคัญ



1. การประเมินและคัดกรอง :

- สร้างสัมพันธภาพให้ผู้ป่วยไว้วางใจ โดยใช้ท่าที่เป็นมิตร และให้การพยาบาลอย่างนุ่มนวล
- ประเมินระดับความวิตกกังวล ความสามารถในการตัดสินใจ และอาการทางจิตเวช
- ประเมินการควบคุมอาการ สามารถควบคุมอาการด้วยยาได้ดี เพื่อเข้ารับการผ่าตัดได้

2. การเตรียมตัวผู้ป่วยและญาติ :

- การให้ข้อมูลที่ชัดเจน อธิบายขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อลดความวิตกกังวล
- การควบคุมยาต่อเนื่อง ต้องได้รับยารักษาอาการทางจิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคกำเริบ หรืออาการถอนยา
- เปิดโอกาสให้ญาติ หรือ ผู้ดูแล เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย



★ การพยาบาลที่สำคัญ



3. การสนับสนุนทางด้านจิตใจ :

- เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึก สอบถามความต้องการของผู้ป่วย
- พุดคุยให้กำลังใจ อยู่เป็นเพื่อน

4. การตรวจสอบความปลอดภัย :

- ตรวจสอบการถอดอุปกรณ์ ของมีค่า เครื่องประดับ และยืนยันการงดน้ำ/อาหาร
- จัดเตรียมอุปกรณ์ผูกยึด (ถ้าจำเป็น) และเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการก้าวร้าวหรืออาละวาด
- หากผู้ป่วย admit สื่อสารกับทีมหอผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย เพื่อเตรียมการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง



แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดผู้ป่วยอาละวาดก้าวร้าว (Code V)

โครงการ Code V for safety
หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์

Case Violence
อาละวาด ก้าวร้าว ทำร้ายผู้อื่น



พยาบาลที่ประเมินคัดกรองพบ แจ้ง “Code V” ขอความช่วยเหลือจากทีม
สื่อสารด้วยป้ายสัญลักษณ์สีแดงตัวอักษร V ติดแฟ้มส่งแพทย์



แพทย์ประเมินอาการและสั่งการรักษาทันที



ผลลัพธ์การดูแล

1. ผู้ป่วยปลอดภัย
2. ทีมดูแลผู้ป่วยปลอดภัยจากการถูกทำร้าย



แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดผู้ป่วยอาละวาดก้าวร้าว (Code V) (ต่อ)

ทีมดูแลเตรียมความพร้อมเพื่อส่งบอการผู้ป่วย

1. ผู้ช่วยพยาบาลคนที่ 1 แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย โทร 97272 “เกิด code V ที่ OPD จิตเวชชั้น 7 ผู้ป่วยชาย/หญิง รูปร่างใหญ่/สั้นท้วม อาละวาดก้าวร้าว ขอทีมรปภ.เสริม จำนวน 4 คน” เมื่อทีมรักษาความปลอดภัยมาพร้อมให้ นำ ป้ายจุดจับระงับเสียง จากระถังใบไม้ แจกให้ทีมรปภ. เพื่อให้ทราบตำแหน่งในการเข้ารวบตัวผู้ป่วย
2. ผู้ช่วยพยาบาลที่ดูแลห้องสังเกตอาการ ติดป้ายสัญลักษณ์ Code V หน้าห้อง และเตรียมห้อง เพลนอน พร้อมเซ็นรณิมาบายมาไว้ในห้อง
3. แยกผู้ป่วยเข้าห้องสังเกตอาการเพื่อให้แพทย์ได้ประเมินอาการและสั่งการรักษา
4. ผู้ช่วยพยาบาลเข้าควบคุมสถานการณ์ ดูแลให้รปภ.เข้าประจำทุกจุดตามป้ายบัตรคำ รอรับคำสั่งให้รวบตัวหากผู้ป่วยเริ่มต่อต้าน
5. พยาบาลรับคำสั่งการรักษา เตรียมยาที่รณิมาบาย
6. ผู้ช่วยพยาบาลนำสายผูกยึดจากระถังใบไม้ ผูกยึดผู้ป่วยตามคำสั่งการรักษาแพทย์
7. ฝ้าระวังจนกว่าผู้ป่วยอาการสงบ



สรุปประเด็น

- ☑️ มาตรฐานการพยาบาลด้านร่างกายเหมือนกัน เน้นการประเมินด้านอารมณ์
- ☑️ การสื่อสารระหว่างทีมดูแล เกี่ยวกับ สภาพจิตใจ การ approach อาการปัจจุบัน ยาที่ได้รับที่มีผลต่อการดมยาสลบ
- ☑️ การจัดการหากเกิดเหตุฉุกเฉิน : Code Violence





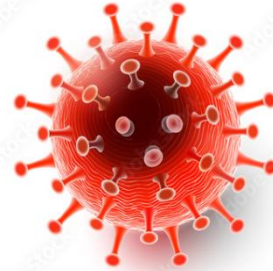
ผู้ป่วย
ติดเชื้อ

Mode of transmission	contact	droplet	airborne
Pathogen or disease	- MDRO (multidrug-resistance organisms) - Skin/Wound infection - Enteric (c-difficile)	- Influenza - Adenovirus - Rhinovirus - Mumps & rubella - Mycoplasma pneumoniae	- Rubeola virus - Varicella zoster virus - Mycobacterium tuberculosis



AIRBORNE/DROPLET PRECAUTIONS

- ประสานงานในการรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อเตรียมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
- แยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยรายอื่น, จำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย
- การใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (PPE)
- การจัดการสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดห้องและอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสัมผัส



COVID-19
CORONAVIRUS





CONTACT PRECAUTIONS

- การบริหารจัดการห้องผ่าตัด : จัดลำดับคิวผ่าตัดเป็นคนสุดท้าย
- การแยกผู้ป่วย: จัดผู้ป่วยแยกไว้ในห้องแยก หรือจัดพื้นที่แยกในการดูแลผู้ป่วย
- การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ : ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย, สวมเครื่องป้องกันแพร่กระจายเชื้อ
- อุปกรณ์: เตรียมอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้ง, ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยด้วยน้ำยาทำลายเชื้อ ได้แก่ 70% alcohol หรือ 1% Virkon

รวมพลังยับยั้งเชื้อดื้อยา




เชื้อดื้อยา คือ เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะเป็นสาเหตุการติดเชื้อหรือ colonization โดยไม่ก่อโรคได้ ติดต่อได้จากการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง หรือ สภาพแวดล้อมรอบผู้ป่วย การศึกษาพบว่า การติดเชื้อดื้อยามี อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น 4 เท่า เมื่อเทียบกับการติดเชื้อที่ไม่ดื้อยา ตัวอย่างเช่น เชื้อดื้อยา CRE และ VRE

เชื้อดื้อยา CRE

(Carbapenem-resistant Enterobacteriales)

คือ เชื้อแบคทีเรีย กลุ่ม Enterobacteriales ที่ดื้อยาในกลุ่ม Carbapenem ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เชื้อ *E.coli*, *Klebsiella species*

เชื้อดื้อยา VRE

(Vancomycin-resistant Enterococci)

คือ เชื้อแบคทีเรีย กลุ่ม Enterococci ที่ดื้อยาในกลุ่ม Vancomycin เช่น เชื้อ *E. faecalis*, *E. faecium*

การป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล



Hygienic Handwashing



เน้นย้ำการล้างมือ 6 ขั้นตอนใน 5 สถานการณ์ คือ

- ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
- ก่อนกำหัดดการ
- หลังสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง
- หลังสัมผัสผู้ป่วย
- หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย

Isolation & Cleaning



- แยกเตียงผู้ป่วยห่างจากเตียงอื่น > 3 ฟุต
- แยกของใช้ของผู้ป่วย
- แจ้งหน่วยงานรับทราบหากมีการเคลื่อนย้าย
- ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบผู้ป่วยด้วย 1% hypochlorite solution อย่างน้อยวันละครั้ง

PPE (Personal Protective Equipment)



ใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น กางเกง เสื้อกาวน์ เชือกคางว่าจะต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

Rational Use of Antibiotics



ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม





สรุปประเด็น

- ☑ มาตรฐานการพยาบาลด้านร่างกายและจิตใจต้องเหมือนกัน
แต่เน้นเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
- ☑ ระบบจัดการห้องผ่าตัด: การจัดลำดับคิวผ่าตัด
- ☑ การเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน: PPE การใช้อุปกรณ์ single-use
- ☑ การทำความสะอาดห้องผ่าตัด, การกำจัดขยะ





Thank you for your attention

